

Fecha Última Actualización: 28-11-2025 10:59:47

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Francisco Antonio Pino Rios
Edad : 66a 7m 19d
Dirección : Los Maitenes # 12 Sec Sta Rita 12

Rut : 7.814.128-K
Fecha Nacto: 09/04/1959
Comuna : Pirque

N° Archivo : 2218234
Sexo : Masculino
Teléfono : 995839575

N° Epicrisis
463570

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Geriatria

Fecha Ingreso : 16/10/2025 00:47

Días Estadía: 43

Unidad de Egreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji

Fecha Egreso : 28/11/2025 10:11

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Anemia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

TUMOR MALIGNO DEL COLON ASCENDENTE - 21/11/2025 00:00 - XIMENA BEATRIZ CONCHA SANHUEZA

Epidemiología

Resumen Clínico

DIAGNÓSTICO

Ca colon ascendente: adenocarcinoma

21.11.25 colectomía derecha laparoscópica con ita mecánica

Probable MTT pulmonares

Estenosis aórtica: TAVI 05/11

Anemia severa secundaria transfundida

Antecedentes:

Ant. mórbidos: HTA, Linfoma de Hodgkin tratado hace 37 años, ICC FEVI 66%, Estenosis aórtica severa con indicación de resolución quirúrgica, anemia en estudio, insuficiencia mitral moderada, insuficiencia tricuspídea moderada

Fármacos: Bisoprolol 1.25 mg cada 12 hrs, Losartan 50 mg 1 cada 12 hrs, furosemida 1/2 cada 12 hrs, aspirina 1 día, ATV 20 mg/día, esomeprazol 20 mg/día

Adherencia: Buena

Antecedentes quirúrgicos: Amputación traumática de pierna derecha (1990)

Alergias: No

Hábitos: Tabaco: (-) OH: (-) Drogas: (-)

Inmunizaciones: Influenza 2025 (-) COVID (4ta dosis) Neumo (-)

Hospitalizaciones previas: Neumonía COVID grave 2022, Anemia severa junio 2025 (extrasistema)

HISTORIA CLÍNICA:

Paciente atendido de forma particular hasta última hospitalización en clínica Dávila por anemia severa y NAC. En esta hospitalización se pesquisa estenosis aórtica severa con indicación de resolución quirúrgica por lo que inicia controles en cardiología HSR. En seguimiento y revisión de exámenes por parte de enfermera de dicha unidad se pesquisa anemia severa por lo que se deriva SU para atención y manejo. Ingres a normocárdico normotenso, afebril. Al interrogatorio dirigido refiere cuadro de 1 semana de somnolencia, disnea de reposo, 2 episodios de lipotimia, falta de fuerza en las 4 extremidades. Se repiten exámenes identificando Hb 5,1 por lo que se indica Tx de 2 ui GR, con control de hemograma post Tx con Hb 7,5. Se indica hospitalización para estudio del cuadro.

Evaluable en SU por hematología indicando paciente con anemia severa microcítica hipocrómica por déficit de hierro, con trombocitosis posiblemente reactiva a esta anemia, indicando que debe realizarse estudio de la etiología de la anemia y

Fecha Epicrisis : 28/11/2025 10:59

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 28-11-2025 10:59:47

Página 2 de 3

reevaluación SOS.

Se decide hospitalizar en UGA para continuar estudio y manejo.

Imagen:

TC TAP (22/10/25): Masa de aspecto tumoral que compromete el polo cecal y la válvula ileocecal compatible con lesión primaria. Esta presenta signos de extensión transmural con presencia de nódulos peritumorales y adenopatías ileomesocólicas de carácter secundario. Tejido perihiliar derecho que se extiende en situación peribronquial a LSD, LM y lóbulo inferior ipsilateral el cual como primera posibilidad corresponde a compromiso secundario de tumor colónico descrito. Una lesión broncogénica primaria parece menos probable. Leve derrame pleural derecho. Ateromatosis cálcica aortocoronario. Gruesas calcificaciones del anillo valvular aórtico y mitral.

Colonoscopia:

(24/10/25) COLONOSCOPIA COMPLETA
TUMOR DE COLON ASCENDENTE BIOPSIADO
PÓLIPOS CECALES NO RESECADOS
PÓLIPOS PEQUEÑOS DE TRANSVERSO Y DESCENDENTE RESECADOS
DIVERTICULOSIS DE SIGMOIDES
LESIONES HIPERPIGMENTADAS EN CANAL ANAL (NO BIOPSIADAS)

Ecocardiograma:

(31/05/25) EcoTT HVI leve con buena función sistólica global y segmentaria FEVI 55%. Dilatación severa de la AI. V. AO estenosis severa con insuficiencia leve a moderada. AO no dilatada. V mitral estenosis leve e insuficiencia leve. CD normales

Evaluado por Anestesia: Paciente de alto riesgo perioperatorio. Estenosis aortica severa contraindica cirugía coloproctológica hasta evaluación por cardiología y eventual resolución

Evaluación Cardiología: Riesgo operatorio prohibitivo por estenosis valvular aortica severa, requiere resolución de valvulopatía antes de pase cardiológico. No candidato a cardiocirugía por comorbilidades, riesgo hemorrágico en relación a tumor colónico y anticoagulación para CEC, además de antecedente de RT torácica.

Candidato a TAVI prioritaria. Se solicita angioTAC protocolo TAVI

Cx Torax: sugiere toma de biopsia por fibrobroncoscopia, se realiza IC. Broncopulmonar: Lesión pulmonar sospechosa de eMTT de tumor colon vs primario. Tiene derrame pleural, podría estudiarse. Miércoles 05/11 para F BC, con pruebas de coagulación y hemograma del día anterior.

05/11/25: TAVI Myval 27 a 27 cc, sin gradiente final, sin insuficiencia perivalvular. Ecocardiograma post TAVI realizado.

06/11/25: presenta peak febril 38.8° se toman hemocultivos 1 y 2, + sedimento y urocultivo, sin foco evidente, sin inicio ATB. Se traslada desde UCO a sala Cx. Infectología define tratamiento ATB con pip/tazo, completa el 11/11/25 sin recurrencia de peak febriles. HC negativos

21.11.25 colectomía derecha laparoscópica con ITA mecánica

Evoluciona favorablemente, hemodinamia estable, afebril, sin req de O2, analgesia adecuada, buena tolerancia oral, tránsito a gases y deposiciones, deambula sin incidentes.

Se realiza fibrobroncoscopia el día 27.11 con tu endobronquial lóbulo medio. se toman biopsias

Se decide alta para seguimiento ambulatorio

Diagnóstico de Egreso

TUMOR MALIGNO DEL COLON -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Evoluciona favorablemente, hemodinamia estable, afebril, sin req de O2, analgesia adecuada, buena tolerancia oral, tránsito a gases y deposiciones, deambula sin incidentes

Se decide alta para seguimiento ambulatorio

Fecha Epicrisis : 28/11/2025 10:59

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:02

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Plan Post Alta

- Reposo relativo en domicilio. Mantenerse activo a tolerancia evitando reposo prolongado en cama.
- Régimen liviano por 5-7 días. Luego, régimen habitual a tolerancia.
- Hidratación con abundante agua (al menos 1 litro al día)
- Cuidados de herida operatoria: puede bañarse normalmente, sin jabonar zona con parches. Secar con secador de pelo.
- Una vez retirados los parches, mantener heridas limpias y secas. No aplicar jabón, alcohol, cremas ni otras sustancias. Retiro de puntos/grapas en pasillo 2 CDT en 10 días.
- Curación herida operatoria diario en cesfam de pique
- Rescatar biopsia de fibrobroncoscopia
- Fármacos:
 - * Paracetamol 500 mg: 2 comprimidos cada 8 horas vía oral x 7 días
 - * metamizol 300 mg 1 comprimido cada 8 hrs vía oral por 3 días
 - * Bisoprolol 1.25 mg cada 12 hrs vía oral
 - * Losartan 50 mg, 1 comprimido cada 12 hrs vía oral
 - * Furosemida 40 mg medio comprimido cada 12 hrs, vía oral
 - * Aspirina 100 mg 1 comprimido al día vía oral
 - * Atorvastatina 20 mg , 1 comprimido al día vía oral
 - * omeprazol 20 mg, 1 comprimido al día vía oral
- Control postoperatorio en DIPRECC en 1 a 2 semanas, se le contactará para coordinar hora de control
- Acudir a Servicio de Urgencias en caso de fiebre (temperatura axilar mayor o igual a 38°C), dolor abdominal intenso que no cede con analgesia, vómitos a repetición o según necesidad
- Avisar alguna duda o en caso de asistir a urgencias avisar al correo coloproctologiahsr@gmail.com

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles

Valentina Ignacia Ríos Correa
INTERNO


Bec. Pablo Guzman Marin
Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)